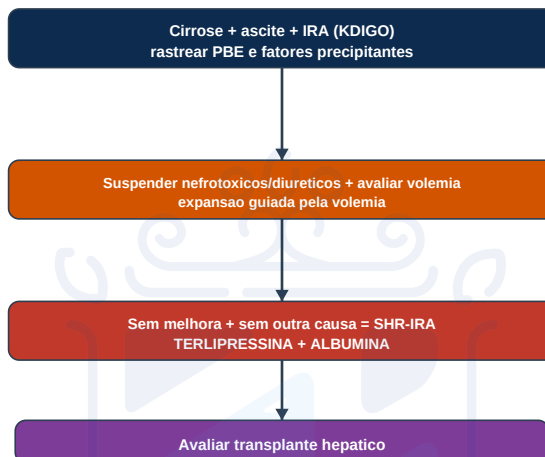


SÍNDROME HEPATORRENAL — CIRROSE + IRA

FLUXOGRAMA — IRA NO CIRRÓTICO

SHR — DIAGNÓSTICO DE EXCLUSÃO



DEFINIÇÃO E FISIOPATOLOGIA

O QUE É

- Lesão renal FUNCIONAL no paciente com cirrose e ascite, sem doença renal estrutural
- Vasodilatação arterial sistêmica e esplâncnica (substâncias vasodilatadoras + translocação bacteriana)
- Resposta: ativação do SRAA e simpático -> vasoconstrição renal intensa + retenção hidrossalina -> IRA
- Padrão: insuficiência renal progressiva SEM hematúria/proteinúria significativas

QUANDO SUSPEITAR E FATORES PRECIPITANTES

BUSCAR O GATILHO

- Cirrose avançada + ascite com piora recente da função renal (creatinina subindo, oligúria)
- Sinais de descompensação hepática: icterícia, encefalopatia, hipotensão (PAS < 100)
- Principal precipitante: PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA (PBE) — sempre puncionar a ascite!
- Outros: hipovolemia (vômitos/diarreia, sangramento digestivo, EXCESSO de diuréticos)
- Medicamentos: AINEs, vasodilatadores, nefrotóxicos, contraste iodado

EXAMES E CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

EXCLUIR OUTRAS CAUSAS

- Creatinina/TFG, urina I (sem hematúria/proteinúria), USG de rins e vias (sem obstrução/estrutural)
- Função hepática: TGO/TGP, FA, GGT, BT, albumina, INR; eletrólitos (sódio urinário tipicamente < 10)
- PARACENTESE diagnóstica: bioquímica, celularidade, citologia, bacterioscopia — investigar PBE
- Rastreio infeccioso: hemograma, PCR, RX tórax, hemoculturas
- Critérios: Cirrose + ascite | IRA (KDIGO) | SEM melhora com expansão | ausência de outra causa de IRA

TRATAMENTO — EXPANSÃO GUIADA PELA VOLEMIA

Rx 1) AVALIAR VOLEMIA ANTES DE EXPANDIR

Hipovolemia: expandir com cristaloídes balanceados até corrigir
Volemia incerta: 250-500 mL de cristaloíde OU albumina 20-25% 1-1,5 g/kg
Euvolemia/hipervolemia: NÃO administrar cristaloíde/albumina de rotina
Avaliar a resposta em 24h (creatinina e/ou débito urinário) — não atrasar o diagnóstico/vasoconstritor
Suspender diuréticos, betabloqueadores e nefrotóxicos; tratar a PBE (ceftriaxona + albumina)

TRATAMENTO — VASOCONSTRITOR + ALBUMINA

Rx 2) BASE DO TRATAMENTO DA SHR-IRA

TERLIPRESSINA (1a escolha): 2-4 mg/dia EV em infusão contínua
Se não reduzir creatinina $\geq$ 25% em 24h: aumentar 2 mg até máx 12 mg/dia
Alternativa: noradrenalina EV (em ambiente monitorizado/UTI)
ALBUMINA 20-25% 20-40 g/dia EM CONJUNTO com o vasoconstritor
Suspender a albumina se houver sinais de SOBRECARGA volêmica
Encaminhar para avaliação de transplante hepático (tratamento definitivo)

RED FLAGS / INTERNAÇÃO

GRAVIDADE

- Instabilidade hemodinâmica / necessidade de vasopressor / choque
- Encefalopatia hepática, sangramento digestivo, PBE
- Oligúria/anúria, necessidade de terapia renal substitutiva
- Internar todos; UTI se instabilidade ou necessidade de DVA
- Calcular MELD; acionar hepatologia / fila de transplante

CRITÉRIOS DE ALTA

ALTA SE

- ☐ Estabilidade hemodinâmica sem vasopressor
- ☐ Creatinina em redução sustentada (< 1,5 mg/dL ou retorno a 0,3 do basal)
- ☐ Ascite controlada, sem necessidade de paracenteses frequentes
- ☐ Fatores precipitantes resolvidos (PBE tratada, nefrotóxicos suspensos, hipovolemia corrigida)
- ☐ Avaliação para transplante encaminhada + orientações de alarme

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Cirrose por ____; SHR-IRA. Precipitante: PBE / HDA / diuréticos. Creatinina ____ (basal ____).
- Sódio urinário < 10; ascite volumosa; encefalopatia grau ____; MELD ____.
- Condutas: expansão guiada pela volemia + terlipressina/noradrenalina + albumina; diuréticos/BB suspensos.
- Solicito suporte terciário (DVA, hemodiálise) e avaliação de transplante hepático.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Cirrótico com ascite e creatinina subindo de 1,0 para 2,5, sem hematúria/proteinúria, USG renal normal, sem melhora após albumina. Diagnóstico e tratamento?

- A) Necrose tubular aguda — apenas hidratação
- B) Síndrome hepatorrenal (SHR-IRA) — terlipressina + albumina
- C) Glomerulonefrite — corticoide
- D) Obstrução urinária — sondagem
- E) Nefrite intersticial — suspender antibiótico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o principal fator precipitante da síndrome hepatorrenal que deve ser ativamente investigado?

- A) Hipertensão arterial
- B) Peritonite bacteriana espontânea (PBE)
- C) Diabetes
- D) Hipotireoidismo
- E) Litíase renal

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o vasoconstritor de primeira escolha no tratamento da SHR-IRA?

- A) Dopamina
- B) Terlipressina (associada à albumina)
- C) Dobutamina
- D) Adrenalina
- E) Vasopressina isolada

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a expansão volêmica na SHR, a conduta atual recomenda:

- A) Expandir todos com 1 g/kg de albumina por 48h, independentemente da volemia
- B) Avaliar a volemia antes: expandir se hipovolemia; não expandir de rotina se euvolêmico/hipervolêmico, reavaliando em 24h
- C) Nunca expandir
- D) Usar apenas cristalóide hipotônico
- E) Restrição hídrica absoluta

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o tratamento DEFINITIVO da síndrome hepatorrenal?

- A) Hemodiálise crônica
- B) Transplante hepático
- C) Terlipressina por tempo indefinido
- D) Paracenteses seriadas
- E) Betabloqueador

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

IRA funcional no cirrótico com ascite, sem doença renal estrutural (urina e USG normais) e sem resposta à expansão = SHR-IRA. Tratamento: vasoconstritor (terlipressina) + albumina, após excluir/tratar precipitantes.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A PBE é o principal fator precipitante da SHR — por isso, todo cirrótico com ascite e piora renal deve ter a ascite puncionada para investigar PBE (e tratá-la com ceftriaxona + albumina).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A terlipressina é o vasoconstritor de primeira escolha na SHR-IRA, sempre associada à albumina; a noradrenalina é alternativa em ambiente monitorizado. Reverte a vasodilatação esplâncnica e melhora a perfusão renal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A diretriz atual recomenda avaliar a volemia antes de expandir (evita atraso do diagnóstico e sobrecarga): expandir se hipovolêmico, não expandir de rotina se euvolêmico/hipervolêmico, reavaliando a resposta em 24h.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O transplante hepático é o tratamento definitivo da SHR, pois corrige a doença de base. Terlipressina + albumina são ponte/tratamento da fase aguda enquanto se avalia o transplante.

SM24
Suporte ao Plantão Médico